

LIQUEN PLANO

María Jesús Suarez Valladares

- El liquen plano es un trastorno autoinmunitario poco frecuente de causa desconocida.
- Se identifican las 5 P: pequeñas placas o pápulas brillantes, poligonales, pruriginosas, de color violáceo-púrpura. Son características unas líneas blancas superficiales denominadas estrías de Wickham.
- Suelen aparecer en muñecas y tobillos. Existen otros patrones que afectan a mucosas o al cuero cabelludo.
- Cursa en brotes y puede tener una resolución espontánea. Lo más habitual es el manejo con corticoides tópicos.

INTRODUCCIÓN

El liquen plano es una enfermedad inflamatoria crónica, poco frecuente, que ocupa el 1% de las consultas dermatológicas. Lo más frecuente es su presentación en la piel, aunque puede afectar también a mucosas (oral o genital).

El origen de la enfermedad radica en una alteración inmunológica donde los linfocitos T atacan a las células de la epidermis provocando esas lesiones inflamatorias. Parece que los brotes pueden estar relacionados con episodios de estrés o ansiedad, algunos fármacos o la infección por una hepatitis C.

DIAGNÓSTICO

Las manifestaciones del liquen plano son bastante típicas por lo que, con un examen cutáneo adecuado y un interrogatorio completo no debería ser necesario llegar a una biopsia que confirme el diagnóstico.

El cuadro típico es un paciente que de forma repentina desarrollan pápulas y placas poligonales de pequeño tamaño, de un característico color violáceo o purpúrico, muy pruriginosas. Es muy característico la aparición de unas pequeñas líneas blancas superficiales en forma de red, conocidas como estrías de Wickham. Suelen afectar a la cara interior de las muñecas, tobillos o parte inferior de la espalda, aunque de forma progresiva se pueden generalizar al tronco y resto de extremidades. (Figura 1)

Hasta en un 50% de las veces pueden tener una afectación de mucosas a nivel lingual, boca y genital. Cuando las lesiones aparecen en mucosa oral se observan unas líneas blanquecinas, eritematosas o erosivas que pueden ocasionar molestias a la hora de ingerir alimentos y que en un porcentaje muy bajo podrían tornar a una lesión maligna. (Figura 2)

Cuando la inflamación causada por el liquen afecta a los folículos pilosos, podemos observar una alopecia parcial o total en la zona con discreto eritema perifolicular y punteado de queratosis característico. Generalmente la pérdida de cabello es irreversible. También, hasta en un 15% de los pacientes existe afectación ungueal que suele provocar la atrofia de la uña (Figura 2).

Otros patrones podrían ser el liquen plano anular, atrófico, hipertrófico, ampollar, pigmentoso, actínico o ungueal.

Cuando se confirma el diagnóstico es recomendable descartar una posible asociación a infecciones víricas (mediante serologías), toma de fármacos o clínica.



Figura 1. Localización típica de lesiones por liquen en muñecas y tobillos. En la última fotografía se puede apreciar con más detalle las típicas pápulas planas poligonales de color violáceo.

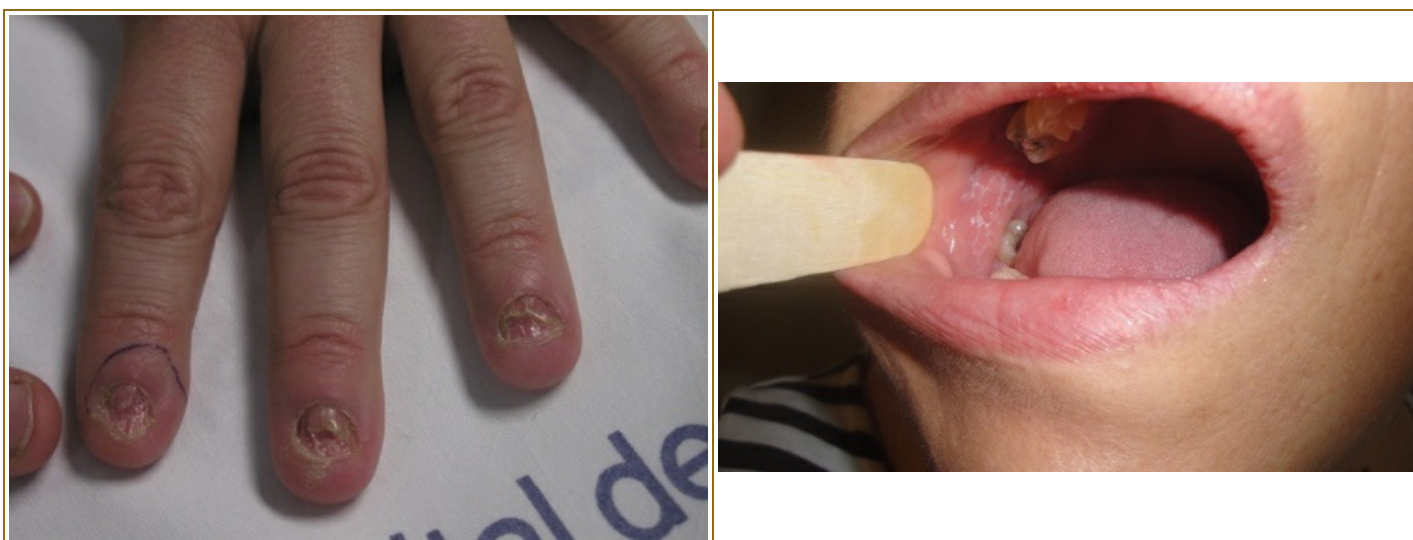


Figura 2. Otras localizaciones menos frecuentes pueden ser la mucosa oral, donde se aprecia el típico reticulado blanquecino. Cuando el liquen afecta a las uñas se observa un adelgazamiento y fragilidad ungueal (onicorrexis) y un despegamiento distal (onicoquisis).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento dependerá de la extensión y sintomatología causada. En muchas ocasiones como ya hemos destacado, cursa en brotes con una duración autolimitada.

- **Corticoides tópicos.** En las formas localizadas, que son las más frecuentes, se puede controlar con corticoides tópicos potentes en crema o emulsión dependiendo de la extensión, la posología adecuada sería aplicar 2 veces al día hasta resolución de lesiones y prurito y posteriormente 1 vez al día durante una semana más para disminuir el riesgo de recidiva.
- **Derivados de la vitamina A.** También es posible combinar los corticoides tópicos con derivados de la vitamina A (tretinoína) tópicos para ahorrar el uso de los corticoides, especialmente cuando las lesiones presentan una hiperqueratosis o escama acusada.
- **Antihistamínicos orales.** Si el paciente presenta mucho prurito se pueden añadir antihistamínicos orales para conseguir un mejor control.

- **Corticoides orales o retinoides orales.** Cuando la enfermedad es más generalizada o no responde al primer escalón de tratamiento, lo más adecuado es derivar a un dermatólogo. En estos casos, se pueden emplear tratamientos sistémicos como los corticoides orales o retinoides orales.
- **Fototerapia.** También es útil la fototerapia (rayos UVA) o el metotrexato.

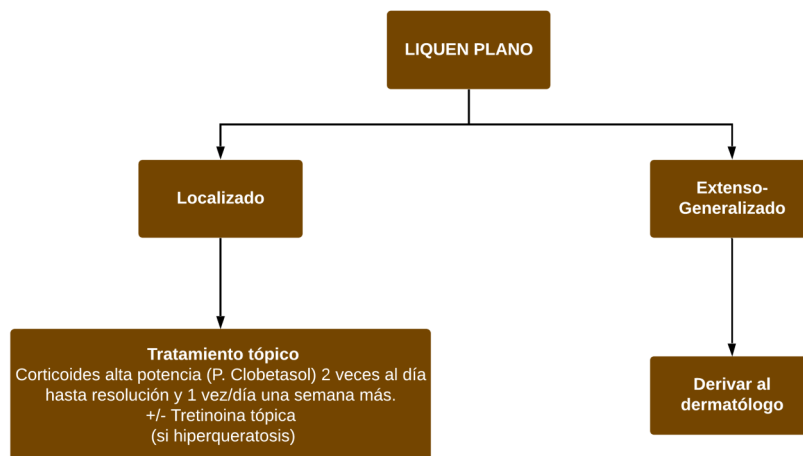


Figura 3. Algoritmo de tratamiento en urgencias de liquen plano según extensión de las lesiones

BIBLIOGRAFÍA

- Rodríguez Acar M, Carbajal Pruneda P. Liquen plano. Revisión de la literatura. Rev Cent Dermatol Pascua 2006;15(3):203-208.
- Usatine RP, Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus. Am Fam Physician. 2011;84(1):53-60.
- Boyd AS, Neldner KH. Lichen planus. J Am Acad Dermatol. 1991;25(4):593-619.
- Pittelkow M, Daoud MS. Lichen planus. En: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Lelfell DJ, Wolff K. Fitzpatrick Dermatología en Medicina General. 7ª ed. Madrid: Médica Panamericana;2009. p.244-55.
- Kwar AJ, De D. Methotrexate for treatment of lichen planus: old drug, new indication. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013; 27(3):e410-13.